

RheumaCheck Fragebogenpaket V6

Audit, Bestandsabgleich und To-do-Liste

Stand: 11.05.2026 | Projektordner erneut verfügbar | Arbeitsstand vor Erstellung Bogen A V6.1

1. Kurzfazit

Der V6-Arbeitsstand ist jetzt methodisch neu geordnet. Die wichtigste Korrektur gegenüber der bisherigen V5.1-Logik ist, dass die Umfrage zur Standardmethode nicht nur als Patienten-Ist-Stand-Bogen verstanden werden sollte, sondern als Rheumanetzwerk-/Ärzteumfrage zur Standardmethode und zum Versorgungspfad. Damit besteht das Fragebogenpaket sinnvollerweise aus vier Modulen: A, B, C und D.

Dieses Dokument hält den aktuellen Bestand fest, benennt die noch fehlenden V6-konformen Bausteine und legt die Reihenfolge der nächsten Arbeitsschritte fest.

2. Quellen- und Dateistatus

Aktueller Zugriff: Der vollständige RheumaCheck-Projektordner liegt wieder vor. Zusätzlich sind die April- und Mai-Protokolle sowie die bereits erzeugten V6-Artefakte verfügbar. Ein erneuter Upload ist für den nächsten Schritt derzeit nicht nötig.

Datei / Pfad	Typ	Relevanz	Status
RheumaCheck_Projekt-Ordner.zip	Original-Projektordner	enthält Antrag, Teilvorhaben, Gantt, Berichte, JF-Protokolle, Zuwendungsbescheid, Präsentationen	verfügbar
Antrag/ Gesamtvorhabenbeschreibung/ RheumaCheck_Gesamtverbund beschreibung_VOLLANTRAG.docx/pdf	Originalquelle	Gesamtlogik: Testdaten, Fragebogen, Plattform, Stratifizierung, Erfolgskontrolle	verfügbar
Antrag/ IMDB_TVH/...Teilvorhabenbeschreibung...	Originalquelle IMDB	AP8, Erfolgskontrolle, Standardmethode, Umfrage unter Rheumanetzwerk-Mitgliedern	verfügbar
Antrag/salvevita_TVH/salvevita Teilvorhabenbeschreibung- VOLLANTRAG.docx/pdf	Originalquelle salvevita	digitale Plattform, interaktive Fragebögen, User-Elemente, elektronische Formulare	verfügbar
Antrag/ IKB_TVH/...Teilvorhabenbeschreibung...	Originalquelle IKB	Patientengruppen, klinische Studie, Stratifizierung, Benutzerfreundlichkeit, Feedback	verfügbar
Berichte/Zwischenbericht 2025/ZB_13GW0761C_20260210.pdf	Bericht	Vorbereitung Umfrage zur Standardmethode in Abstimmung mit IKB	verfügbar
2026_04_09_RC_JF- Protokoll_HPE.pdf	Jour fixe	Grobabstimmung mit Robert; danach Feinabstimmung mit Michael; Tasks getrennt dokumentiert	verfügbar
2026_05_07_RC_JF- Protokoll_HPE_V2_c.pdf	Jour fixe	IMDB hat erste Vorarbeiten zu Fragebögen/Begleitforschung begonnen; weitere Schärfung nötig	verfügbar

Hinweis: Die Originalquellen werden im nächsten Quellenpaket V6.2 erneut mit konkreten Fundstellen/Screenshots ausgeleitet, wenn Bogen A und C aktualisiert sind.

3. Aktueller Artefaktbestand

Baustein	Datei / Stand	Status	Bewertung
V6 Architektur / Quellenkonzept	RheumaCheck_Fragebogenarchitektur_V6_Quellen_und_Konzept_2026-05-11.docx/pdf	vorhanden	Führender Überbau für V6
Masterprompt V6	RheumaCheck_Masterprompt_F	vorhanden	Produktionslogik für vier Module

	fragebogenpaket_V6_2026-05-11.docx/pdf		
Bogen B V6.1	2026_05_11_RheumaCheck_BogenB_Rheumanetzwerk_Standardmethode_V6_1.docx/pdf	vorhanden	Neu erstellt; V6-konform
Bogen D V6.1	2026_05_11_RheumaCheck_BogenD_Aerztliche_Implementierbarkeit_V6_1.docx/pdf	vorhanden	Neu erstellt; V6-konform
Roter Faden V6.2	2026_05_11_RheumaCheck_Fragebogenprojekt_Roter_Faden_V6_2.docx/pdf	vorhanden	Mitlaufendes Steuerungsdokument
Bogen A alt	V5.1/V3-Pilot: Vorab-Anamnese / Stratifizierung	vorhanden, aber noch nicht V6.1	muss jetzt V6-konform neu gefasst werden
Bogen C alt	V5.1/V3-Pilot: Usability / Erfolgskontrolle	vorhanden, aber noch nicht V6.1	muss danach V6-konform neu gefasst werden

4. V6-Modulstruktur: Zielbild

Modul	Arbeitstitel	Zielgruppe	Kerninhalt	Status
A	Patienten-Vorab-Anamnese / Stratifizierung	Patient:innen mit Verdacht / Frühsymptomen	Symptome, Dauer, kleine Gelenke, Morgensteifigkeit, Funktion, Vorbefunde, Triagehinweise	fehlt als V6.1
B	Rheumanetzwerk-/Ärztumfrage zur Standardmethode und zum Versorgungspfad	Rheumanetzwerk, Ärzt:innen, Versorgungsakteure	heutiger Standardweg, Verzögerungen, Diagnostikpfad, Therapieeinleitung, Versorgungslücken	V6.1 erstellt
C	Patienten-Usability / Ergebnisverständnis / Versorgungsnutzen	Patient:innen/ Testnutzer:innen	Verständlichkeit, App/Testdurchführung, Vertrauen, wahrgenommener Nutzen, Ergebnisverständnis	fehlt als V6.1
D	Ärztliche Implementierbarkeit / erwarteter Nutzen	Ärzt:innen, Rheumatolog:innen, Hausärzt:innen, Ambulanzen	klinische Einsatzorte, Evidenzanforderungen, Workflow, Barrieren, Pilotbereitschaft	V6.1 erstellt

5. Fachlicher Abgleich: Was ist belegt, was ist Ableitung?

Thema	Quelle / Herleitung	Konsequenz	Sicherheit
Patienten-Anamnese / Stratifizierung	aus Gesamtvorhaben, IKB-Logik und Plattformaufwertung ableitbar	Bogen A erforderlich	hoch
Interaktiver / digitaler Fragebogen	aus salvevita-Plattformlogik, App/CUBE/Workflow und elektronischen Formularen ableitbar	alle Bögen sollten digitalisierbar sein	hoch
Umfrage zur Standardmethode	im IMDB-Arbeitspaket und Zwischenbericht als Standardmethoden-Umfrage beschrieben	Bogen B erforderlich	sehr hoch
Rheumanetzwerk-Zielgruppe	im IMDB-AP8 als Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks beschrieben	Bogen B muss ärztlich/versorgungsstrukturell sein	sehr hoch
Usability / Erfolgskontrolle	aus IMDB-Erfolgskontrolle, salvevita-UI/Workflow und IKB-Benutzerfeedback ableitbar	Bogen C erforderlich	hoch
Ärztliche Implementierbarkeit / erwarteter Nutzen	fachlich sinnvoll; teilweise aus AP8, IKB- und Implementierungslogik abgeleitet	Bogen D sinnvoll, aber als Ergänzungsmodul kennzeichnen	mittel bis hoch

6. To-do-Liste und Reihenfolge

Schritt	Aufgabe	Inhalt	Status / nächster Schritt
1	Audit und Bestandsabgleich V6	dieses Dokument	erledigt mit Erstellung dieses Dokuments
2	Bogen A V6.1 neu erstellen	Patienten-Vorab-Anamnese und Stratifizierung	nächster Produktionsschritt
3	Bogen C V6.1 neu erstellen	Patienten-Usability, Ergebnisverständnis, Versorgungsnutzen	danach
4	Konsolidiertes Fragebogenpaket	A+B+C+D, Quellenlogik,	nach A/C

	V6.2	Zielgruppenmatrix, digitale Struktur, Entscheidungsmatrix	
5	Finaler QA-Durchgang	Inhalt, Zielgruppen, Dopplungen, Deadlines, Layout, Druckbarkeit, Tabellenränder	letzter Schritt vor Weitergabe

7. Qualitäts- und Layoutregeln für die nächsten Artefakte

- Tabellen bleiben innerhalb der normalen Seitenränder; keine Tabelle darf bis an den Rand laufen oder über den Rand hinausragen.
- Überschriften und Firmen-/Bogenblöcke erhalten sichtbaren Abstand nach oben.
- Deadlines in Task-Tabellen werden weitergeführt und nicht stillschweigend gelöscht.
- Die Tasks "Grobabstimmung mit Robert Lange" und "Feinabstimmung mit Michael Zänker" bleiben getrennt und sequenziell.
- Patientenbögen und Ärzte-/Rheumanetzwerkbögen werden klar getrennt, damit Zielgruppen nicht vermischt werden.
- Alle Bögen werden als Word/PDF erzeugt, gerendert und visuell geprüft; zusätzlich wird bei Paketständen ein ZIP erstellt.

8. Entscheidung vor dem nächsten Produktionsschritt

Der nächste sinnvolle Produktionsschritt ist Bogen A V6.1. Dabei wird die vorhandene Substanz aus der alten V5.1/V3-Pilotfassung übernommen, aber an die neue V6-Architektur angepasst. Ziel ist ein sauberer Patientenbogen, der klinische Voranamnese, Stratifizierung und digitale Weiterverarbeitung berücksichtigt und klar von Bogen B und D abgegrenzt ist.

Danach folgt Bogen C V6.1. Erst wenn A und C V6-konform vorliegen, wird das konsolidierte Gesamtpaket V6.2 erzeugt.

9. Offene Punkte für spätere Abstimmung

Adressat	Offene Frage
Robert Lange / salvevita	Welche Fragen werden direkt digital/interaktiv? Welche Felder müssen maschinenlesbar sein? Welche Sprunglogik ist realistisch?
Michael Zänker / IKB	Welche Symptome und klinischen Kriterien sind für Stratifizierung entscheidend? Welche Patientengruppen und Abläufe sind realistisch?
Frank Bier / IMDB	Welche IMDB-Beiträge sind methodisch/analytisch zu übernehmen? Wie werden Fragebogen- und Testdaten später ausgewertet?
Rheumanetzwk	Wer genau soll Bogen B erhalten? Nur Rheumatologie oder auch Hausärzte, Ambulanzen, MVZ und diagnostische Akteure?

10. Dokumentationsstand

Dieses Audit-Dokument ist der Startpunkt für die nächste Produktionsrunde. Es ersetzt nicht die Originalanträge oder die V6-Architekturdatei, sondern dient als operative Arbeits- und Kontrollliste. Es sollte zusammen mit dem Roter-Faden-Dokument fortgeschrieben werden, sobald Bogen A V6.1 und Bogen C V6.1 erstellt sind.